

Urticaria medicamentosa — diagnóstico y manejo clínico

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, Guía EAACI/WAO 2022 sobre urticaria, British Association of Dermatologists 2024, UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

La **urticaria medicamentosa** es una **reacción adversa cutánea de tipo inmediato (hipersensibilidad tipo I)**, mediada principalmente por **IgE o activación directa de mastocitos**, que provoca la liberación de **histamina y otros mediadores inflamatorios**.

Se manifiesta por **ronchas pruriginosas evanescentes** y, en algunos casos, **angioedema**.

Relevancia clínica

- Es una **reacción frecuente a fármacos** (especialmente antibióticos y AINES).
- Generalmente **benigna**, pero puede ser el **inicio de una anafilaxia**, por lo que su **identificación precoz es crucial**.
- Es una **pregunta recurrente en EUNACOM**, tanto en diagnóstico diferencial como en manejo farmacológico (antihistamínicos, corticoides, adrenalina).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Tipos de urticaria inducida por fármacos

Tipo	Mecanismo	Ejemplo
Alergia verdadera (inmunológica)	Reacción tipo I (IgE mediada) ; sensibilización previa al fármaco.	Penicilina, cefalosporinas, anestésicos
No inmunológica (pseudalérgica)	Activación directa de mastocitos o complemento , sin IgE.	AINES, opiáceos, medios de contraste

Por depósito de inmunocomplejos (tipo III)	Vasculitis urticariana, más tardía y persistente.	Sulfas, alopurinol
--	---	--------------------

2.2. Mecanismo inmunológico principal

1. Exposición al fármaco → **unión a IgE específica** fijada en mastocitos y basófilos.
2. Liberación de **histamina, prostaglandinas, leucotrienos y bradiquinina**.
3. Aumento de **permeabilidad vascular** → formación de habones y edema.

2.3. Factores predisponentes

Factor	Ejemplo
Fármacos implicados	Penicilinas, cefalosporinas, AINES, contrastes yodados, opiáceos, quinolonas, insulina
Condiciones asociadas	Infecciones virales (VEB, hepatitis), atopía, asma, polifarmacia
Factores genéticos	Predisposición familiar a urticaria o alergias
Edad / sexo	Más frecuente en adultos jóvenes y mujeres

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesiones características

- **Ronchas (habones)** eritematosas, sobreelevadas, bien delimitadas.
 - **Altamente pruriginosas**, de aparición **rápida (minutos a horas)** tras exposición.
 - Cada lesión individual **desaparece en menos de 24 horas**, aunque pueden aparecer nuevas.
 - **Distribución generalizada o localizada.**
-

3.2. Angioedema

- Ocurre en hasta un **40% de los casos**.
 - Edema súbito, profundo y no pruriginoso de **párpados, labios, lengua o laringe**.
 - Riesgo vital si compromete vía aérea.
 - Puede aparecer **con o sin urticaria concomitante**.
-

3.3. Cronología típica

- **Reacción inmediata:** minutos a 1 hora después de la exposición (típico de IgE mediada).
 - **Reacción tardía:** horas a días (mecanismos mixtos o no IgE).
 - **Primera exposición:** requiere sensibilización previa; la urticaria aparece tras reexposición.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Exantema maculopapular medicamentoso	Lesiones fijas, no evanescentes, no pruriginosas, sin angioedema

Anafilaxia	Urticaria + síntomas sistémicos: hipotensión, disnea, sibilancias, vómitos
Vasculitis urticariana	Lesiones >24 h, dolorosas, dejan púrpura residual
Urticaria física (frío, presión, calor)	Relacionada a estímulo físico, no a fármacos
Urticaria colinérgica	Lesiones pequeñas tras ejercicio o calor
Reacción a picaduras	Localizada, con centro puntiforme visible

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico se basa en:

1. **Temporalidad clara** entre la exposición al fármaco y aparición de lesiones.
 2. **Lesiones típicas urticariformes**, evanescentes y pruriginosas.
 3. Resolución rápida tras suspensión del medicamento.
-

4.2. Exámenes complementarios (solo si hay duda)

- **Hemograma:** puede mostrar leucocitosis o eosinofilia leve.
- **IgE total o específica (RAST):** útil solo en alergias a betalactámicos confirmadas.
- **Pruebas cutáneas (prick test, intradermorreacción):** para penicilinas y anestésicos, bajo supervisión especializada.

- **Biopsia cutánea:** solo en sospecha de vasculitis urticariana (infiltrado neutrofílico con daño endotelial).

4.3. Diagnóstico de anafilaxia (criterios NIAID/FAAN 2022)

Debe sospecharse si urticaria o angioedema se acompaña de:

- Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor).
- Hipotensión o síncope.
- Náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea.

En este caso, el manejo debe ser **urgente con adrenalina intramuscular**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / EAACI / AAD)

5.1. Medidas iniciales

- **Suspender de inmediato el fármaco sospechoso.**
 - Identificar si la reacción es **localizada, generalizada o con compromiso sistémico**.
-

5.2. Tratamiento de la urticaria leve a moderada

Tipo de medida	Fármaco / dosis	Comentario
Antihistamínico oral (primera línea)	Loratadina 10 mg/día, cetirizina 10 mg/día, fexofenadina 180 mg/día	Elección inicial; no sedantes

Antihistamínicos de segunda generación en dosis altas	Duplica dosis (hasta 4x la habitual si persistente)	Recomendado por guías EAACI 2022
Corticoide sistémico corto (si persistente o extensa)	Prednisona 0.5 mg/kg/día por 3–5 días	Alivia más rápido el prurito e inflamación
Corticoides tópicos	Poca utilidad; solo si lesiones localizadas	Complementario
Evitar AINES, alcohol y estrés	Pueden exacerbar el cuadro	—

5.3. Tratamiento del angioedema o urticaria severa

- **Monitoreo de vía aérea.**
 - **Adrenalina intramuscular (0.3–0.5 mg en adultos, 0.01 mg/kg en niños)** en muslo anterolateral si hay compromiso respiratorio o hipotensión.
 - **Oxígeno, líquidos EV e hidratación.**
 - **Antihistamínicos IV (clorfenamina 10 mg) y corticoides IV (hidrocortisona 100 mg)** si compromiso extenso.
-

5.4. Tratamiento de la urticaria persistente inducida por fármacos

- Confirmar eliminación del fármaco causal.
- Si persiste >6 semanas → **urticaria crónica espontánea inducida**, tratar según protocolo:
 - Antihistamínicos en dosis altas.
 - **Omalizumab** (anticuerpo anti-IgE) si refractaria.

5.5. Educación y prevención

- Registrar el fármaco en ficha clínica y **tarjeta de alergia**.
 - Evitar medicamentos con estructura similar (p. ej. penicilinas ↔ cefalosporinas).
 - Derivar a **alergología** si reacción grave o necesidad de confirmación diagnóstica.
 - Explicar al paciente cómo reconocer **síntomas de alarma** (disnea, edema laríngeo, síncope).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Anafilaxia	Evolución potencialmente fatal; requiere adrenalina inmediata
Angioedema laríngeo	Obstrucción de vía aérea, causa de muerte súbita
Vasculitis urticariana	Lesiones persistentes >24 h con púrpura residual
Urticaria crónica	Si persiste >6 semanas; requiere estudio etiológico
Impacto psicológico	Ansiedad ante uso de medicamentos futuros

Pronóstico:

- En la mayoría de los casos, resolución completa en 24–48 h tras suspensión del fármaco y tratamiento antihistamínico.
- Riesgo de recurrencia si reexposición accidental.

- En reacciones graves, mortalidad <1% con manejo adecuado.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Reacción más rápida y pruriginosa** a un medicamento → *urticaria medicamentosa*.
 2. Lesiones **evanescentes (<24 h), sobreelevadas y eritematosas**.
 3. **Antihistamínicos de segunda generación** son primera línea.
 4. **Angioedema con compromiso respiratorio** → **adrenalina IM urgente**.
 5. Evitar etiquetar como “alérgico a todo”, salvo confirmación específica.
 6. En **EUNACOM**, clave: “*Paciente con urticaria y disnea tras penicilina* → *diagnóstico: anafilaxia, manejo con adrenalina IM.*”
-



Errores comunes

- Continuar el fármaco causal “porque la urticaria es leve”.
 - Prescribir corticoides prolongadamente sin suspender el agente.
 - Usar antihistamínicos de primera generación sedantes (difenhidramina) en adultos mayores.
 - No educar al paciente sobre el uso de **autoinyector de adrenalina** si antecedente grave.
 - No distinguir entre urticaria aislada (benigna) y anafilaxia (emergencia vital).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **urticaria medicamentosa** es una **reacción de hipersensibilidad inmediata (tipo I, IgE mediada)**, con aparición rápida de ronchas pruriginosas y evanescentes.
2. Los **fármacos más comunes** son antibióticos β -lactámicos y AINES.
3. El **diagnóstico es clínico**, basado en la temporalidad y la morfología típica.
4. El tratamiento de elección es **antihistamínico no sedante**; se agregan corticoides orales si extensa o persistente.
5. En presencia de **angioedema o síntomas respiratorios** → **adrenalina intramuscular inmediata**.
6. Registrar el medicamento causante en ficha clínica y **evitar reexposición**.
7. En **EUNACOM**, recordar:
 - “Lesiones evanescentes, pruriginosas y migratorias tras antibiótico → urticaria medicamentosa.”
 - “Si asocia disnea o hipotensión → anafilaxia (adrenalina IM).”